UNIÃO METROPOLITANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (UNIME)

CURSO DE ODONTOLOGIA

Disciplina: Atenção Odontológica nos Ciclos de Vida – Bebês, Crianças e Adolescentes

Professora: Grazielle Marçal Barbosa

Rafael Morais da Silva

CARTILHA DE CONSULTA RÁPIDA: TERAPÊUTICA MEDICAMENTOSA NO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO INFANTIL

Fármacos, doses pediátricas, cálculos e casos clínicos

Lauro de Freitas

2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....3
1.1 Objetivos.....3
2 AVALIAÇÃO DA CRIANÇA E PRESCRIÇÃO SEGURA.....3
3 ANESTÉSICOS LOCAIS E VASOCONSTRITORES.....4
3.1 Características farmacológicas.....4
3.2 Vasoconstritores e prevenção de acidentes.....5
3.3 Método de cálculo.....5
4 DOR E INFLAMAÇÃO.....5
4.1 Analgésicos.....5
4.2 Anti-inflamatórios: AINEs e corticosteroides.....6
5 INFECÇÕES: ANTIBIÓTICOS E PROFILAXIA.....7
5.1 Tratamento antibiótico.....7
5.2 Profilaxia antibiótica.....7
6 CÁLCULO DE DOSES E PREVENÇÃO DE ERROS.....8
7 ANTISSÉPTICOS, TÓPICOS, ANTIFÚNGICOS E ANTIVIRAIS.....9
8 CASOS CLÍNICOS.....9
8.1 Caso clínico 1 – Dor odontológica em criança asmática.....9
8.2 Caso clínico 2 – Infecção odontogênica.....10
8.3 Caso clínico 3 – Anestesia local em paciente cardiopata.....10
9 CONCLUSÃO.....11
REFERÊNCIAS.....11

1 INTRODUÇÃO

Prescrever para uma criança é um ato de maior risco do que prescrever para um adulto. O peso corporal é pequeno e muda rapidamente, o fígado e os rins ainda estão em maturação e a diferença entre a dose eficaz e a dose tóxica costuma ser estreita. Por isso, uma conta feita às pressas ou uma bula lida pela metade pode produzir uma intoxicação. Em Odontopediatria, soma-se a isso um princípio clínico: o medicamento trata o sintoma ou controla a infecção, mas só o procedimento odontológico remove a causa (AAPD, 2024).

Esta cartilha foi organizada como material de consulta rápida. Reúne quadros comparativos, doses expressas por administração e por dia, cálculos com todas as etapas e três casos clínicos. As informações foram cruzadas entre o *Reference Manual of Pediatric Dentistry* (AAPD, 2024), o manual de anestesia local de Malamed (2020), a diretriz da American Heart Association sobre endocardite (WILSON et al., 2021) e as bulas do Bulário Eletrônico da Anvisa (BRASIL, [s.d.]). Quando as fontes divergem, a diferença é apontada. Os valores servem de apoio ao raciocínio e não substituem a leitura da bula vigente.

1.1 Objetivos

O objetivo geral é oferecer um guia de consulta que apoie a prescrição racional, segura e individualizada em crianças e adolescentes. Os objetivos específicos são: comparar analgésicos, anti-inflamatórios, antibióticos, anestésicos e demais fármacos quanto a indicação e segurança; demonstrar os cálculos de dose e de anestésico; diferenciar profilaxia de tratamento; e aplicar esses conceitos em casos clínicos.

2 AVALIAÇÃO DA CRIANÇA E PRESCRIÇÃO SEGURA

Antes de escolher qualquer fármaco, a anamnese deve responder a seis perguntas: quanto a criança pesa hoje; qual é a idade; se há alergia ou reação prévia a medicamentos; se há doenças de base (cardiopatia, asma, hepatopatia, nefropatia, diabetes, imunossupressão); quais medicamentos já estão em uso, inclusive os comprados sem receita; e se o responsável conseguirá cumprir o esquema. O peso deve ser aferido na consulta, e não estimado pela idade.

As interações e duplicidades merecem atenção especial. Exemplos frequentes são o uso simultâneo de dois anti-inflamatórios, a soma de paracetamol

isolado com xaropes para gripe que também o contêm, a associação de fluconazol com midazolam, que potencializa a sedação, e a de macrolídeos com fármacos que prolongam o intervalo QT. O ácido acetilsalicílico deve ser evitado em crianças com infecções virais pelo risco de síndrome de Reye.

A receita precisa trazer o nome genérico, a concentração, a dose em mg e em mL, o intervalo, a duração e a via, com letra legível, de preferência com recomendação de seringa dosadora em vez de colher caseira. Aos responsáveis, orienta-se: guardar os medicamentos fora do alcance das crianças; nunca repetir a dose por conta própria; não misturar produtos com o mesmo princípio ativo; concluir o antibiótico no prazo prescrito; e retornar se não houver melhora. Os sinais de gravidade que exigem atendimento de urgência ou encaminhamento hospitalar são: dificuldade para respirar ou engolir, trismo, edema de assoalho da boca, pescoço ou região dos olhos, febre alta persistente, prostração, desidratação, rápida progressão do edema, alteração da consciência e reação alérgica sistêmica (AAPD, 2024).

3 ANESTÉSICOS LOCAIS E VASOCONSTRITORES

3.1 Características farmacológicas

Os anestésicos locais impedem a entrada de sódio na fibra nervosa e, com isso, bloqueiam a condução do estímulo doloroso. No Brasil, os tubetes odontológicos têm 1,8 mL. A lidocaína 2% com epinefrina 1:100.000 é a opção mais usada em crianças. A articaína 4% tem boa difusão, mas a bula não a recomenda abaixo de 4 anos. A mepivacaína 3% é alternativa quando se deseja evitar o vasoconstritor, porém tem ação mais curta. A prilocaína 3% com felipressina é opção para pacientes cardiopatas, com risco de metemoglobinemia em doses altas. A bupivacaína não é indicada em crianças, pois sua longa duração favorece a mordedura de lábio e língua (MALAMED, 2020).

Quadro 1 – Anestésicos locais em tubetes de 1,8 mL: conversões e limites de dose

Anestésico	Concentração	mg/mL	mg por tubete	Limite (mg/kg)	Teto absoluto	Comentário
Lidocaína 2% + epinefrina 1:100.000	2%	20	36	4,4	300 mg	Referência em crianças; ação pulpar de cerca de 1 h.
Mepivacaína 3% simples	3%	30	54	4,4 (AAPD); 6,6 (Malamed)	300 mg; 400 mg	Ação curta. Fontes divergem; usar o valor mais conservador.
Articaína 4% + epinefrina 1:100.000	4%	40	72	7,0	500 mg	Não recomendada em menores de 4 anos (bula).

Anestésico	Concentração	mg/mL	mg por tubete	Limite (mg/kg)	Teto absoluto	Comentário
Prilocaína 3% + felipressina 0,03 UI/mL	3%	30	54	6,0	400 mg	Opção em cardiopatas; atenção à metemoglobinemia.
Bupivacaína 0,5% + epinefrina 1:200.000	0,5%	5	9	1,3	90 mg	Evitar em crianças.

Fonte: elaborado pelo autor, com base em MALAMED (2020), AAPD (2024) e BRASIL ([s.d.]).

3.2 Vasoconstritores e prevenção de acidentes

A epinefrina e a felipressina aumentam a duração do bloqueio, reduzem o sangramento e retardam a absorção do anestésico, o que diminui o risco de toxicidade. Em contrapartida, a epinefrina deve ser limitada a 0,2 mg por sessão em pacientes saudáveis e a 0,04 mg em cardiopatas ASA III e IV (MALAMED, 2020). Cada tubete 1:100.000 contém 0,018 mg. A toxicidade sistêmica começa com zumbido, gosto metálico, agitação e fala arrastada e pode evoluir para convulsão e parada cardiorrespiratória. Para evitar acidentes, deve-se calcular a dose pelo peso real, aspirar antes de injetar, depositar o anestésico devagar (cerca de 1 mL por minuto) e descontar o anestésico tópico já usado. Em crianças, o osso é menos denso, de modo que a técnica infiltrativa costuma bastar, inclusive em muitos casos na mandíbula de decíduos, e a anestesia prolongada exige orientação aos responsáveis para que a criança não morda lábio, língua e bochecha.

3.3 Método de cálculo

O raciocínio segue sempre a mesma sequência. Primeiro, a porcentagem é convertida em mg/mL multiplicando-se por 10. Segundo, multiplica-se a concentração pelo volume do tubete para obter os miligramas por tubete. Terceiro, calcula-se a dose máxima multiplicando o limite em mg/kg pelo peso, sem ultrapassar o teto absoluto. Quarto, divide-se a dose máxima pelos mg do tubete, o que dá o número máximo teórico de tubetes. Quinto, repete-se a conta para o vasoconstritor. O fator que resultar no menor número de tubetes é o limitante. Por fim, define-se uma margem de segurança, arredondando para baixo e planejando usar bem menos que o teto. O exemplo completo está no Caso Clínico 3.

4 DOR E INFLAMAÇÃO

4.1 Analgésicos

Na dor odontogênica aguda, o analgésico deve ser prescrito em horários regulares por 24 a 72 horas, junto ao tratamento da causa. O paracetamol e a

dipirona são indicados para dor leve a moderada e para febre; o ibuprofeno é preferido quando há componente inflamatório, como na pulpite e no pós-operatório de exodontias (AAPD, 2024). Codeína e tramadol são contraindicados em menores de 12 anos pelo risco de depressão respiratória, e a nimesulida também é contraindicada abaixo dessa idade no Brasil (BRASIL, [s.d.]).

Quadro 2 – Analgésicos em Odontopediatria: doses por administração e diárias

Fármaco	Ação e indicação	Dose por administração	Intervalo	Limite diário	Contraindicações e cuidados
Paracetamol	Ação central; dor leve a moderada, febre	10–15 mg/kg	4 a 6 h	75 mg/kg/dia, até 4 g	Hepatopatias. Risco de lesão hepática na superdose; verificar associações com paracetamol.
Dipirona	Inibe COX e relaxa musculatura lisa; dor e febre	10–25 mg/kg	6 h	4 doses/dia	Menores de 3 meses ou 5 kg; alterações hematológicas; deficiência de G6PD. Agranulocitose é rara.
Ibuprofeno	Inibe COX-1 e COX-2; dor inflamatória	5–10 mg/kg	6 a 8 h	40 mg/kg/dia	Menores de 6 meses; úlcera; insuficiência renal; asma com sensibilidade a AINE; dengue suspeita; varicela.
Opioides e nimesulida	—	Não usar	—	—	Contraindicados em menores de 12 anos.

Fonte: elaborado pelo autor, com base em AAPD (2024) e BRASIL ([s.d.]).

4.2 Anti-inflamatórios: AINEs e corticosteroides

Os AINEs bloqueiam a ciclo-oxigenase e reduzem a produção de prostaglandinas. Os corticosteroides agem mais acima, inibindo a fosfolipase A2 e a expressão de mediadores inflamatórios, e por isso têm efeito mais potente e mais amplo, inclusive sobre a imunidade. Em crianças, o AINE por poucos dias resolve a maior parte dos casos; o corticosteroide deve ser reservado para situações específicas e sempre em ciclo curto, depois de afastada uma infecção ativa sem controle (Quadro 3).

Quadro 3 – AINEs e corticosteroides: diferenças e precauções

Característica	AINEs	Corticosteroides
Alvo principal	COX-1 e COX-2	Fosfolipase A2 e transcrição de citocinas
Quando usar	Dor inflamatória, pós-operatório, febre	Edema ou trismo intensos, trauma extenso, reação alérgica
Dose de referência	Ibuprofeno 5–10 mg/kg a cada 6–8 h; máximo de 40 mg/kg/dia	Prednisolona 0,5–2 mg/kg/dia (usual, 1 mg/kg) em dose única pela manhã, por 3 a 5 dias
Principais efeitos adversos	Dor gástrica, lesão renal, broncoespasmo, sangramento	Hiperglicemia, irritabilidade, queda da imunidade, cicatrização lenta, supressão adrenal em uso prolongado
Contraindicações e precauções	Úlcera, doença renal, asma sensível a AINE, desidratação, dengue; evitar dois AINEs juntos	Infecção sistêmica não controlada, herpes e varicela ativos; evitar junto com AINE
Uso racional	Menor dose, menor tempo, boa hidratação	Apenas com benefício evidente, sem repetir ciclos sem reavaliação

Fonte: elaborado pelo autor, com base em AAPD (2024) e BRASIL ([s.d.]).

5 INFECÇÕES: ANTIBIÓTICOS E PROFILAXIA

5.1 Tratamento antibiótico

A infecção odontogênica é tratada, em primeiro lugar, pela remoção da fonte: acesso endodôntico, pulpectomia, exodontia ou drenagem. O antibiótico **não é necessário** na pulpite, no abscesso localizado e drenável, na fístula sem sintomas sistêmicos e na dor sem infecção. Ele **é indicado** quando existem febre, mal-estar, linfadenopatia, celulite ou edema difuso, quando a drenagem não é possível ou há imunossupressão, sempre somado ao tratamento odontológico (AAPD, 2024). A escolha leva em conta o diagnóstico, a gravidade, a alergia a penicilinas e as doenças associadas. Os cursos devem ser curtos, em geral de 5 a 7 dias, com reavaliação em 48 a 72 horas. Antibióticos desnecessários ou prolongados selecionam bactérias resistentes e provocam diarreia e candidíase; se não houver melhora, o primeiro passo é revisar o tratamento da causa e não trocar por um fármaco de espectro mais amplo.

Quadro 4 – Antibióticos de uso em Odontopediatria

Fármaco	Situação	Dose diária	Divisão e duração	Observações
Amoxicilina	Primeira escolha	25–50 mg/kg/dia	8/8 h (ou 12/12 h); 5 a 7 dias	Não ultrapassar a dose do adulto. Contraindicada em alergia a penicilinas.
Amoxicilina com clavulanato	Falha da amoxicilina; quadros mais extensos	25–50 mg/kg/dia (de amoxicilina)	8/8 ou 12/12 h, conforme a formulação	Causa diarreia com frequência; administrar com alimento.
Penicilina V	Casos leves, alternativa	25–50 mg/kg/dia	6/6 h	Esquema trabalhoso, menor adesão.
Clindamicina	Alergia a penicilinas	10–25 mg/kg/dia	6/6 ou 8/8 h	Risco de colite pseudomembranosa; suspender se houver diarreia intensa.
Azitromicina	Alternativa em alérgicos	10 mg/kg no 1º dia (máx. 500 mg); 5 mg/kg/dia nos dias 2 a 5 (máx. 250 mg)	1 vez ao dia	A bula traz 10 mg/kg/dia por 3 dias. Pode prolongar o QT.
Metronidazol	Associado a β-lactâmico para anaeróbios	15–30 mg/kg/dia	8/8 h	Não deve ser usado sozinho nas infecções odontogênicas.

Fonte: elaborado pelo autor, com base em AAPD (2024) e BRASIL ([s.d.]).

5.2 Profilaxia antibiótica

A profilaxia consiste em **uma única dose antes do procedimento** para prevenir endocardite infecciosa, e não deve ser confundida com o tratamento de uma infecção já instalada, que exige vários dias de antibiótico. A AHA restringe a indicação aos pacientes de maior risco: prótese valvar ou material protético no

reparo valvar, endocardite prévia, cardiopatia congênita cianótica não corrigida ou paliada, cardiopatia congênita reparada com material protético (nos 6 primeiros meses, ou sem limite de tempo se houver defeito residual) e transplante cardíaco com valvulopatia (WILSON et al., 2021). Só se aplica a procedimentos que manipulam a gengiva ou a região periapical ou perfuram a mucosa. Não está indicada para anestesia em tecido sadio, radiografias, ajuste de aparelhos ortodônticos removíveis, esfoliação de decíduos e pequenos traumas labiais. O risco é sempre avaliado caso a caso e, havendo dúvida, o cardiologista deve ser consultado.

Quadro 5 – Profilaxia da endocardite: dose única 30 a 60 minutos antes do procedimento

Condição do paciente	Fármaco	Dose pediátrica
Sem alergia, via oral	Amoxicilina	50 mg/kg (máx. 2 g)
Impossibilidade de via oral	Ampicilina, cefazolina ou ceftriaxona	50 mg/kg IM ou IV (máx. 1 a 2 g)
Alergia a penicilinas	Cefalexina (sem história de anafilaxia, angioedema ou urticária)	50 mg/kg (máx. 2 g)
Alergia a penicilinas	Azitromicina ou claritromicina	15 mg/kg (máx. 500 mg)
Alergia a penicilinas	Doxiciclina	2,2 mg/kg (máx. 100 mg)

Fonte: adaptado de WILSON et al. (2021). A clindamicina deixou de ser recomendada pela AHA em 2021, pelo risco de colite.

6 CÁLCULO DE DOSES E PREVENÇÃO DE ERROS

Duas expressões de dose causam confusão. A dose **por administração** (mg/kg/dose) vale para cada tomada, enquanto a dose **diária** (mg/kg/dia) é o total do dia e precisa ser dividida pelo número de tomadas. Para transformar miligramas em mililitros, calcula-se primeiro a concentração do frasco (mg ÷ mL) e depois divide-se a dose pela concentração. Uma suspensão de 250 mg/5 mL, por exemplo, tem 50 mg/mL; já a de 500 mg/5 mL tem 100 mg/mL, e trocar uma pela outra dobra a dose.

Exemplo – Erro de interpretação de mg/kg/dia (criança de 14 kg)
Prescrição: amoxicilina 250 mg/5 mL, 14 mL de 8/8 h, com a justificativa de “50 mg/kg”.
1) Concentração: 250 mg ÷ 5 mL = 50 mg/mL.
2) Dose por tomada: 14 mL × 50 mg/mL = 700 mg → 700 ÷ 14 kg = **50 mg/kg por tomada**.
3) Dose diária: 3 × 700 mg = 2.100 mg → 2.100 ÷ 14 = **150 mg/kg/dia**, o triplo do limite de 50 mg/kg/dia.
4) Interpretação: o prescritor tratou 50 mg/kg/dia como se fosse por dose.
5) Correção: 50 mg/kg/dia × 14 kg = 700 mg/dia → ÷ 3 = 233 mg por dose → 233 ÷ 50 = **4,7 mL a cada 8 h**.

Outros erros a procurar na receita: associação de dois AINEs ou de dois produtos com paracetamol; confusão entre gotas e mililitros; dose superior à do adulto; ausência de duração; e apresentação comercial diferente da calculada. Toda conta deve ser refeita antes de entregar a receita.

7 ANTISSÉPTICOS, TÓPICOS, ANTIFÚNGICOS E ANTIVIRAIS

Quadro 6 – Antissépticos, anestésicos tópicos, antifúngicos e antivirais

Agente	Indicação	Posologia ou uso	Limitações e cuidados
Clorexidina 0,12% (bochecho)	Controle químico do biofilme por curto período	10–15 mL, 2 vezes ao dia, em crianças que sabem cuspir (em geral > 6 anos)	Pigmentação dentária e alteração do paladar; não engolir.
Clorexidina 2%	Limpeza de cavidade e antissepsia local	Aplicação tópica	Raramente causa alergia; evitar olhos e ouvido.
Hipoclorito de sódio 0,5–2,5%	Irrigação endodôntica	Seringa sem pressão e isolamento absoluto	Irritante para pele e olhos; risco de extrusão apical.
Povidona-iodo 10%	Antissepsia perioral	Aplicação tópica	Alergia a iodo, doença da tireoide e recém-nascidos.
Benzocaína 20% ou lidocaína tópica	Anestesia da mucosa antes da punção	Pequena quantidade em mucosa seca	Metemoglobinemia; evitar benzocaína < 2 anos; contar na dose total de lidocaína.
Nistatina 100.000 UI/mL	Candidíase pseudomembranosa	1 mL (lactentes) a 4–6 mL (maiores), 4 vezes ao dia, retendo na boca; 7–14 dias e 48 h após a cura	Pouca absorção; higienizar chupetas e próteses. Conferir bula.
Fluconazol	Candidíase refratária ou em imunossuprimidos	6 mg/kg no 1º dia e 3 mg/kg/dia por 7–14 dias	Hepatotoxicidade; interação com midazolam.
Aciclovir	Gengivoestomatite herpética primária (até 72 h de evolução); herpes labial	VO: 15 mg/kg/dose, 5 vezes ao dia por 7 dias, ou esquema da bula por idade (100–200 mg); creme 5%, 5 vezes ao dia por 4–5 dias	Hidratar e controlar a dor; ajustar na doença renal.

Fonte: elaborado pelo autor, com base em AAPD (2024) e BRASIL ([s.d.]).

8 CASOS CLÍNICOS

8.1 Caso clínico 1 – Dor odontológica em criança asmática

Menina de 10 anos, 35 kg, com asma persistente leve em uso de bombinha e crises de falta de ar após tomar “remédio para dor” no passado (a família não sabe o nome). Queixa de dor intensa, espontânea e noturna há três dias no dente 46, com cárie profunda; EVA 8/10. Não há edema, fístula nem febre.

Análise. A história é compatível com pulpite irreversível sintomática, e o tratamento definitivo é o endodôntico, ou a exodontia se o dente não puder ser mantido. Como há suspeita de asma agravada por AINE, o ibuprofeno e outros anti-inflamatórios não esteroidais devem ser evitados até esclarecimento. A analgesia fica com o paracetamol, com a dipirona como alternativa, e o corticosteroide não é necessário. Recomenda-se esclarecer com o pediatra qual medicamento provocou as crises.

Cálculo – Paracetamol 200 mg/mL (35 kg)
1) Dose escolhida: 12,5 mg/kg (faixa 10–15 mg/kg) × 35 kg = **437,5 mg por dose**.
2) Volume: 437,5 mg ÷ 200 mg/mL = 2,19 mL → **2,2 mL (440 mg) a cada 6 h**.
3) Dose diária: 4 × 440 mg = 1.760 mg → 1.760 ÷ 35 = 50,3 mg/kg/dia (limite 75 mg/kg/dia = 2.625 mg; e 4 g/dia). Dentro do limite.
4) Alternativa: dipirona 500 mg/mL, 15 mg/kg × 35 kg = 525 mg → 525 ÷ 500 = **1,05 mL (≈ 1 mL = 500 mg = 14,3 mg/kg) a cada 6 h**.
5) Interpretação: usar por 48 a 72 h em horários fixos e reavaliar; dor persistente indica que a causa não foi resolvida.

8.2 Caso clínico 2 – Infecção odontogênica

Menino de 8 anos, 25 kg, sem alergias. Na primeira consulta, apresenta fístula com secreção na gengiva do dente 84 (necrose pulpar), sem dor intensa, sem edema e sem febre.

Situação A – sem sinais sistêmicos. O tratamento é odontológico: pulpectomia ou exodontia do dente 84 e controle da fístula. **Antibiótico não está indicado**, pois a infecção está localizada e já drena (AAPD, 2024).

Situação B – disseminação. Cinco dias depois, a criança volta com febre de 38,5 °C, edema facial difuso na região mandibular, linfadenopatia e inapetência, mas respira, engole e abre a boca normalmente. Além da intervenção local no mesmo dia, indica-se **amoxicilina**, com revisão em 48 a 72 horas. Em alergia a penicilinas, utiliza-se clindamicina.

Situação C – gravidade. Dificuldade para respirar ou engolir, trismo, edema no assoalho bucal, pescoço ou ao redor dos olhos, prostração, desidratação ou piora rápida exigem **encaminhamento hospitalar imediato** para antibiótico intravenoso, drenagem e monitorização, sem esperar resposta ao antibiótico por via oral.

Cálculo – Situação B (25 kg)
1) Amoxicilina 40 mg/kg/dia × 25 kg = 1.000 mg/dia → ÷ 3 = 333 mg por dose (abaixo da dose do adulto, 500 mg).
2) Suspensão 250 mg/5 mL = 50 mg/mL → 333 ÷ 50 = **6,7 mL a cada 8 h, por 7 dias** (21 doses = 140 mL).
3) Alergia a penicilinas: clindamicina 15 mg/kg/dia × 25 kg = 375 mg/dia → ÷ 3 = 125 mg; solução 75 mg/5 mL = 15 mg/mL → 125 ÷ 15 = **8,3 mL a cada 8 h** (faixa de 10–25 mg/kg/dia).
4) Interpretação: doses dentro da faixa pediátrica; orientar sobre diarreia e retorno se não houver melhora em 48–72 h.

8.3 Caso clínico 3 – Anestesia local em paciente cardiopata

Menino de 8 anos, 28 kg, ASA III por cardiopatia congênita (comunicação interventricular) corrigida cirurgicamente há 3 anos, compensado, sem defeito

residual nem uso de prótese. Será realizada restauração com anestesia infiltrativa no dente 85, com **articaína 4% com epinefrina 1:100.000**, tubete de 1,8 mL.

Cálculo – Articaína 4% com epinefrina 1:100.000 (28 kg)
1) Concentração: 4% = 4 g/100 mL = 4.000 mg/100 mL = **40 mg/mL**.
2) Por tubete: 40 mg/mL × 1,8 mL = **72 mg**.
3) Dose máxima: 7 mg/kg × 28 kg = **196 mg** (inferior ao teto de 500 mg).
4) Tubetes pela articaína: 196 ÷ 72 = **2,72 tubetes**.
5) Epinefrina 1:100.000 = 0,01 mg/mL × 1,8 mL = **0,018 mg/tubete**. Limite para cardiopata: 0,04 mg → 0,04 ÷ 0,018 = **2,2 tubetes**. (Em paciente saudável, 0,2 mg permitiria 11,1 tubetes.)
6) Fator limitante: a **epinefrina** (2,2 < 2,72). Margem de segurança: no máximo 2 tubetes (0,036 mg, 90% do limite); no plano clínico, 1 tubete (72 mg = 2,6 mg/kg; 0,018 mg), mais que suficiente para uma restauração.

Interpretação. Neste caso, ao contrário do paciente saudável, o limite é determinado pelo vasoconstritor e não pelo anestésico. Recomenda-se aspirar, injetar lentamente, usar o menor volume efetivo e manter contato com o cardiologista. Como o defeito foi corrigido há mais de 6 meses, sem material residual de risco, a **profilaxia antibiótica não está indicada** (WILSON et al., 2021). Uma alternativa é a prilocaína 3% com felipressina (54 mg/tubete; 6 mg/kg × 28 = 168 mg, ou 3,1 tubetes), que dispensa a epinefrina.

9 CONCLUSÃO

A prescrição racional em Odontopediatria depende de alguns princípios simples e inegociáveis: confirmar o diagnóstico e tratar a causa; pesar a criança e individualizar a dose; distinguir dose por administração de dose diária e conferir a concentração do frasco; respeitar o limite do anestésico e do vasoconstritor e adotar margem de segurança; reservar o antibiótico às infecções com indicação e a profilaxia aos cardiopatas de alto risco; evitar associações e fármacos proibidos na infância; e orientar os responsáveis, reconhecendo precocemente os sinais de gravidade. Com esses cuidados, o medicamento deixa de ser um risco e passa a ser um aliado do cuidado clínico.

REFERÊNCIAS

AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRIC DENTISTRY (AAPD). **The reference manual of pediatric dentistry**. Chicago: AAPD, 2024. (Inclui as diretrizes sobre anestesia local, manejo da dor e antibioticoterapia em odontopediatria.) Disponível em: https://www.aapd.org/. Acesso em: 10 nov. 2026.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). **Bulário Eletrônico**. Brasília, DF: Anvisa, [s.d.]. Disponível em: https://consultas.anvisa.gov.br/#/bulario/. Acesso em: 10 nov. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Relação Nacional de Medicamentos Essenciais: Rename 2022**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2022.

MALAMED, Stanley F. **Handbook of local anesthesia**. 7. ed. St. Louis: Elsevier, 2020.

WILSON, Walter R. et al. Prevention of viridans group streptococcal infective endocarditis: a scientific statement from the American Heart Association. **Circulation**, Dallas, v. 143, n. 20, p. e963–e978, 2021.